

LOULI IDP 创业管理班 / 合作洽谈

楼里：让下一站更清楚

室内导航商业计划与试点合作讨论稿

我们希望和场馆共同验证 用一层楼或一段短流程，帮助访客找到目的地，让场馆知道哪里需要改善。先形成可评估的服务，再扩展定位、系统接入与年度维护。

为什么有机会

医院首次就诊者需要知道“下一项做什么、去哪里、怎样到达”；商场顾客需要找到门店、设施和返回位置。找路问题是否值得付费，要以各场馆现状和试点结果判断。

医院官方采购已有导航项目：洛阳东方医院 2025 年公告预算 20 万元；常州市第一人民医院 2025 年合同 69 万元。[1][2]这些案例证明采购存在，范围各异，不能作为楼里的售价或目标客户预算。

我们提出什么

- **医院流程包** 科室与服务点查询、院方确认的任务顺序、地标式路线、流程提醒。
- **商场到达包** 门店与公共设施查询、楼层路线、无障碍路径、信息错误反馈。
- **增强服务** 经授权再评估真实队列、停车/会员接口与手机定位；现场测试后确定验收范围。

当前证据与交付边界

已有医院、商场网页仿真，演示路线、多点任务和模拟队列。尚无授权客户地图、真机定位性能、生产系统接入或成交记录。管理端、真实地图配置与现场部署为拟交付项；不能把演示数值称作实际效果。

这次洽谈希望得到什么

一次 30 分钟业务访谈、一层楼勘察许可、一位业务及地图维护负责人。共同确定问题、范围、验收与预算路径，之后决定是否开展试点。

2026 年 10 月 7 日 版本 1.0 价格、成本和排期为讨论假设。

详细来源、客户提问与研究缺口见配套《商业调研与客户访谈手册》。

01 谁会购买

医院与商场分别确认价值

销售要找到两个人 愿意推动试点的业务负责人，以及能确认预算和签约路径的购买方。用户喜欢演示，还不足以形成订单。

	医院	商场
使用者	患者、家属、行动不便者	顾客、停车用户、访客
业务推动人 (待确认)	门诊办、患者服务/导诊团队	客服运营、商业运营、会员数字化
技术与签约	信息科、采购部门、院方或集成商	IT、物业、集团数字化；场馆或集团签约
痛点假设	科室别名、多点任务、跨层找路、反复问路	找店/设施、跨层路线、返回停车位置
首轮范围	一层楼、2—4 个服务节点；扫码起点、人工流程规则	一层楼、指定门店与设施；扫码起点、目录与路线
验证价值	到达成功、找路时间、问路次数、规则正确	到达成功、找店时间、客服问路、目录维护耗时
收入方式	部署项目费+年度维护；接口/定位单列	部署与目录服务+年度维护；停车/会员单列

先选择能验证的问题

优先选择业务负责人愿意参与、地图可授权、入口可曝光、目标可测量的场景。医院检查顺序和前置要求由院方确认；商场到店不等于购买，初期不承诺营收增长。

已有方案决定我们怎样进入

高德、百度和专业厂商已有室内地图、检索与路线能力；蜂鸟视图官方产品还提供多种导航偏好和多端模板。[3][4][5]楼里应验证业务流程配置、地标指引与小范围服务是否带来额外价值，避免仅重复一张地图。

优先渠道

医院：业务访谈+信息科评估，并与有院内交付经验的集成商讨论患者服务模块。商场：运营/客服访谈+集团数字化评估，先进入现有官方入口。专业地图/定位供应商可作为供应链候选，合作条件尚未确认。

暂不进入的收入故事

不出售患者与位置轨迹，不以广告转化做保底承诺；不将信标硬件单卖当作已验证的主业务。先判断客户是否愿意为服务与维护付费。

02 试点合作

四至六周，验证一条短路线

首轮建议 一层楼、20—30 个目的地、固定扫码起点；使用授权地图与匿名任务记录。4—6 周为双方资源到位后的计划假设，具体工期在确认范围后确定。

双方提供什么

场馆提供	地图授权；科室/店铺名称与通行规则；现场观察与二维码放置许可；业务、技术和维护对接人
楼里拟交付	路线页面与目录、扫码起点、异常回退与反馈、配置台账、培训及验收报告；相关功能按合同开发交付
另行确认	信标布设与真机兼容；队列/预约、停车/会员接口；部署环境、第三方许可和安全要求

试点如何推进

- 1. **范围与基线** 访谈、勘察，确认最易迷路的节点与当前找路方式，签署地图授权和指标口径。
- 2. **配置与走查** 整理地图/目录，验证路径与无障碍信息；场馆负责人审核流程规则。
- 3. **小范围使用** 在同一路线与相近时段安排基线/试点任务，记录到达、时间、问路与异常；首轮建议 30—50 次任务。
- 4. **共同复盘** 看实际改善、入口使用率、维护成本与购买路径，再决定扩展、改进或停止。

预先确定验收，防止演示代替效果

目标到达率 = 无额外问路到达的任务数 ÷ 有效任务数；找路时间报告中位数并注明路线、熟悉度与时段。记录二维码曝光、打开、路线开始与完成，解释用户是否愿意用。小样本只说明可行性，不直接代表全馆效果。

拟议继续条件：重大路线错误为零；目标到达/时间相对基线有改善；有人维护；客户确认后续采购路径。具体阈值须在开始前共同签字，当前没有客户确认的指标。

什么时候停止或缩减

没有地图授权、入口无法放置、无人维护、已有系统足够或关键接口不可得。首轮保留手动起点与现场导诊回退；定位和实时队列未验证时，不能承诺持续实时导航。

03 商业模式

按工作量报价，让一单算得清

以下金额全部为内部讨论假设 尚未勘察、询价或成交，不能当作正式报价。历史医院采购金额与楼里小试点范围不同，不用于锚定售价。

产品/服务	讨论金额	范围说明
访谈+勘察+试点设计	0.3—0.8 万元	是否抵扣部署费协商
医院单层短流程试点	2—5 万元	20—30 个 POI、扫码起点，无生产接口/实时定位
商场单层到达服务	1.5—4 万元	已有授权地图；无停车/会员接口
年度维护	0.6—1.8 万元	更新次数、响应、托管与许可边界写明
全馆/定位/接口增强	另行估算	现场验证、接口确认、供应商询价后报价

单位经济示例：一单医院扫码路线试点

假设收入 30,000 元。12 人日×800 元= 9,600 元，地图整理 2,000 元，托管 600 元，现场差旅 1,800 元，测试培训 2,000 元，风险预留 2,000 元；交付成本合计 18,000 元。获客与商务投入另计 4,000 元。

增量贡献 = 30,000—18,000—4,000 = 8,000 元（26.7%）。这是税前贡献，未扣研发、固定支出、折旧与融资成本，不能称为净利润。

情景	收入	交付	获客	贡献
基准	30,000	18,000	4,000	8,000
降价 20%	24,000	18,000	4,000	2,000
增加 6 人日	30,000	22,800	4,000	3,200
另加 15% 渠道费	30,000	18,000	8,500	3,500
工期与渠道同时增加	30,000	22,800	8,500	—1,300

签约前最值得控制的三项成本

限制接口与地图变更范围；问清第三方许可/托管与设备维保；确定预付款、验收付款与售后责任，减少垫资。渠道费是否与原获客投入重叠，应按合作协议重算。

复购来自维护价值，仍待验证

年度收入 12,000 元、更新支持/托管等成本 6,000 元时，增量贡献为 6,000 元（假设）。续费率和获客周期未知，暂不计算客户终身价值或三年收入。先记录每单真实工时与维护需求，判断是否能复制。

04 从演示到合作

先取得真实购买证据

下一轮的成功标准 一位愿意推动的业务负责人、一块授权场地、一个可比基线、一个明确预算/采购路径。它们比未经验证的市场规模更有用。

建议的获客节奏

先做 6—10 次跨角色访谈（工作计划，尚未完成），每次保留痛点证据、现有替代、预算状态与下一步。选一场馆做范围明确的试点；取得书面使用与成果展示许可后，再形成可分享案例。第二场馆用于验证交付与维护是否能复制。

第一次会议问这六件事

1. 最近最常见的问路有哪些？是否有客服/导诊记录？
2. 现有地图、官方入口和供应商哪里不够用？
3. 谁推动、谁维护、谁批预算、谁签合同？
4. 能提供什么地图授权、现场许可与接口条件？
5. 愿意试哪条路线，如何测量并验收？
6. 试点通过后，用哪项预算、经过什么采购流程？

官方渠道与当前限制

医院按官网当前调研/采购公告进入；本地历史市场调研显示公司材料、产品参数与售后很重要。[6]商场先请服务台或官方账号转介运营/数字化负责人；集团客服仅为转介入口。[7] 西溪银泰城仅是未来地图导入候选，未取得地图授权、合作或当前对接人。

暂无需购买白皮书。免费官方资料足以支撑首轮洽谈；最大空白是客户需求、授权、预算与接入。若后续购买，优先考察医院导航采购与购物中心数字服务预算主题，先验作者、样本、年份、方法与样章，不凭市场规模图购买。

来源与证据等级

- [1] 洛阳东方医院采购公告（2025-06-06，预算，非成交）。 [2] 常州市政府采购合同公告（2025-05-13，合同）。
[3] 高德室内地图产品。 [4] 百度室内地图产品。 [5] 蜂鸟视图导航导览产品（均为官方产品说明，非独立性能测试）。
[6] 杭州市第一人民医院 2025 年 7 月市场调研（历史报名已结束）。 [7] 银泰官方综合事项渠道、龙湖官方天街服务渠道（非采购负责人）。

研究截至 2026-10-07；完整案例、链接、访谈清单和缺口见配套 MD。本稿无市场总量外推、无已签客户、无真实定位精度或销售增长承诺。